

CAPÍTULO 2.6

Complicaciones Mecánicas del Infarto Miocárdico

Las **complicaciones mecánicas del infarto agudo al miocardio (IAM)** son eventos graves que pueden ocurrir en la fase aguda o subaguda de un infarto. Son de vital importancia debido a su alta morbilidad y la necesidad de un diagnóstico y manejo rápidos.

Características Generales de las Complicaciones Mecánicas del IAM

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Tiempo de aparición: Suelen ocurrir horas o pocos días después del infarto, con la inmensa mayoría presentándose dentro de la primera semana. Diagnóstico clave: Todas se estudian con una Ecocardiografía. Manejo principal: La gran mayoría de estas complicaciones se manejan quirúrgicamente.

Tipos de Complicaciones Mecánicas Post-IAM

Existen cuatro complicaciones mecánicas principales que son fundamentales conocer:

- Rotura de músculo papilar
- Rotura de tabique interventricular
- Rotura de pared libre
- Aneurismas y pseudoaneurismas ventriculares

1. Rotura de Músculo Papilar

NOTA CLÍNICA

El músculo papilar es crucial para la función de la válvula mitral, ya que las cuerdas tendinosas se insertan en sus velos. Su rotura provoca una disfunción severa de la válvula, llevando a una Insuficiencia Mitral Aguda.

**Clínica:** Presenta un **soplo holosistólico** de nueva aparición, que puede ser de alta intensidad. Causa una rápida **descompensación hemodinámica** con signos de **Insuficiencia Cardíaca** aguda y **Edema Pulmonar**. **Diagnóstico:** La **Ecocardiografía** confirmará la rotura del músculo papilar y la presencia de insuficiencia mitral severa. **Manejo:** Requiere **cirugía urgente** para la reimplantación del músculo o el reemplazo/reparación de la válvula mitral.

2. Rotura de Tabique Interventricular

NOTA CLÍNICA

La rotura del tabique interventricular crea una comunicación directa entre el ventrículo izquierdo y el derecho (una **Comunicación Interventricular** adquirida), lo que resulta en un shunt de izquierda a derecha y sobrecarga del ventrículo derecho y la circulación pulmonar.

**Clínica:** Se manifiesta con un **soplo holosistólico** intenso, a menudo palpable. Causa **descompensación hemodinámica** con **Insuficiencia Cardíaca** y **Edema Pulmonar**. **Importante:** La presentación clínica es muy similar a la rotura de músculo papilar, por lo que la **Ecocardiografía** es indispensable para el diagnóstico diferencial. **Diagnóstico:** La **Ecocardiografía** identificará el defecto septal y el flujo de sangre a través del shunt. **Manejo:** La **cirugía urgente** para cerrar el defecto septal es el tratamiento de elección.

3. Rotura de Pared Libre

NOTA CLÍNICA

Esta es la complicación mecánica más letal. La rotura de la pared muscular del ventrículo permite que la sangre se extravase rápidamente al pericardio, formando un **Hemopericardio** que conduce a un **Taponamiento Cardíaco** agudo.

**Clínica:** La presentación es **radicalmente diferente** a las anteriores. El paciente entra en **Shock cardiogénico fulminante**. Puede presentar la **Triada de Beck**: hipotensión, ruidos cardíacos apagados y **yugulares ingurgitadas**. Con mucha frecuencia, el paciente sufre **muerte súbita** debido al colapso hemodinámico rápido. **Diagnóstico:** La **Ecocardiografía** es crucial para identificar el hemopericardio masivo y los signos de taponamiento. **Manejo:** Es una emergencia quirúrgica extrema. A pesar de la intervención, el pronóstico es sombrío.

4. Aneurisma y Pseudoaneurisma Ventricular

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La distinción entre un aneurisma y un pseudoaneurisma es clave por su diferente riesgo de rotura.

TABLA 2.6.1: CARACTERÍSTICA VS ANEURISMA VENTRICULAR

| CARACTERÍSTICA     | ANEURISMA VENTRICULAR                                                          | PSEUDOANEURISMA VENTRICULAR                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición         | Dilatación sacular de la pared ventricular.                                    | Contención de la rotura miocárdica por el pericardio.                                                 |
| Capas involucradas | Incluye las <b>tres capas</b> del corazón: endocardio, miocardio y pericardio. | Pierde <b>al menos una capa</b> (generalmente miocardio), siendo el saco contenido por el pericardio. |
| Riesgo de rotura   | Relativamente bajo.                                                            | <b>Más alto</b> , debido a su pared más delgada y frágil.                                             |

**Clínica:** A menudo son **asintomáticos** y se descubren de forma incidental en un **Ecocardiografía** de control post-IAM. Pueden generar **embolias sistémicas** si se forman trombos en su interior que luego se desprenden. Existe un riesgo, aunque menor para el aneurisma verdadero, de **rotura**, lo que se manifestaría como una rotura de pared libre. **Hallazgo clásico en EKG:** Un signo clásico es el **supradesnivel persistente del segmento ST** en el electrocardiograma, semanas o meses después del infarto, **sin dolor torácico ni otros síntomas de Síndrome Coronario Agudo**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Es fundamental diferenciar un supradesnivel del ST persistente por aneurisma de un nuevo evento isquémico. La clave es la **ausencia de clínica de isquemia aguda** (dolor torácico, etc.) en el caso del aneurisma crónico.

**Diagnóstico:** La **Ecocardiografía** es el examen de elección para visualizar la lesión, diferenciar entre aneurisma y pseudoaneurisma, y evaluar la presencia de trombos. **Manejo:** Los **aneurismas pequeños y asintomáticos** pueden ser **observados** y manejados de forma conservadora. Los **pseudoaneurismas** y los aneurismas grandes, sintomáticos (por embolias, insuficiencia cardíaca) o con alto riesgo de rotura, generalmente requieren **corrección quirúrgica**.

Resumen Diagnóstico y Terapéutico

**Diagnóstico:** Ante la sospecha de cualquier complicación mecánica post-IAM, la **Ecocardiografía** es el pilar diagnóstico, permitiendo una identificación precisa y una evaluación de la severidad. **Tratamiento:** En la mayoría de los casos, el manejo es **quirúrgico y de urgencia**, dada la gravedad y el riesgo vital que implican estas complicaciones. Solo aneurismas ventriculares pequeños y asintomáticos podrían ser candidatos a observación.

El reconocimiento temprano y la intervención oportuna son esenciales para mejorar el pronóstico de los pacientes con estas graves complicaciones del infarto.

### CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

#### ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 68 años, día 4 post IAMSDST anterior, presenta súbitamente soplo holosistólico nuevo en borde esternal izquierdo bajo, con frémito palpable. PA cae a 75/50 mmHg con signos de shock cardiogénico."

#### EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Soplo holosistólico nuevo post-IAM sugiere rotura del septum interventricular (CIV post-infarto) o insuficiencia mitral aguda por rotura de músculo papilar. Ambas son emergencias quirúrgicas. La CIV post-IAM ocurre típicamente en día 3-5 post-infarto. Diagnóstico: Ecocardiograma urgente. Tratamiento: estabilizar con balón de contrapulsación intraaórtico + cirugía urgente.

#### PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las complicaciones mecánicas son más frecuentes en infartos no reperfundidos
- La rotura de pared libre causa taponamiento cardíaco y tiene mortalidad mayor al 90% sin cirugía
- La CIV post infarto produce soplo holosistólico nuevo con cortocircuito izquierda-derecha
- La rotura del músculo papilar posteromedial es más frecuente por su irrigación única
- Todas las complicaciones mecánicas requieren cirugía urgente
- El balón de contrapulsación intraaórtico es útil como puente a la cirugía
- Ocurren típicamente entre el día 1 y 7 post infarto

### EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPLICACIONES MECÁNICAS DEL INFARTO MIOCÁRDICO)

#### PREGUNTA 1

Paciente en día 4 post IAM anterior no reperfundido presenta deterioro hemodinámico súbito con soplo holosistólico nuevo y thrill paraesternal. ¿Cuál es la complicación más probable?

- A)** Rotura de pared libre
- B)** Comunicación interventricular post infarto
- C)** Insuficiencia mitral aguda
- D)** Reinfarto
- E)** Pericarditis post infarto

#### PREGUNTA 2

Paciente post IAM inferior presenta edema pulmonar agudo súbito con soplo sistólico nuevo en ápex. Ecocardiograma muestra insuficiencia mitral severa con valva posterior flail. ¿Cuál es el mecanismo?

- A)** Dilatación del anillo mitral
- B)** Rotura del músculo papilar posteromedial
- C)** Endocarditis infecciosa
- D)** Calcificación valvular
- E)** Comunicación interventricular

#### PREGUNTA 3

Paciente en día 5 post IAM presenta dolor torácico súbito, hipotensión, ingurgitación yugular y disociación electromecánica. ¿Diagnóstico y conducta?

- A)** Reinfarto, reperfusión urgente
- B)** TEP masivo, trombolisis
- C)** Rotura de pared libre con taponamiento, pericardiocentesis y cirugía urgente
- D)** Shock cardiogénico, inotrópicos
- E)** Arritmia ventricular, desfibrilación

**RESUMEN: COMPLICACIONES MECÁNICAS DEL INFARTO MIOCÁRDICO**

Las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio son eventos graves que ocurren generalmente en los primeros días post infarto y tienen alta mortalidad. Incluyen la rotura de pared libre ventricular, la comunicación interventricular (CIV) y la insuficiencia mitral aguda por rotura del músculo papilar. Son más frecuentes en infartos no reperfundidos. La rotura de pared libre es la más letal y ocurre típicamente entre el día 3 y 5 post infarto. Se presenta con taponamiento cardíaco y shock. La CIV post infarto produce un cortocircuito de izquierda a derecha con sobrecarga de volumen y se diagnostica por un soplo holosistólico nuevo y confirmación ecocardiográfica con Doppler color. La rotura del músculo papilar causa insuficiencia mitral aguda severa con edema pulmonar, más frecuente con el músculo papilar posteromedial en infartos inferiores. El tratamiento de todas las complicaciones mecánicas es quirúrgico urgente. La estabilización preoperatoria incluye vasodilatadores, balón de contrapulsación intraaórtico y soporte inotrópico. El pronóstico sin cirugía es ominoso, con mortalidad superior al 90% en rotura de pared libre y cercana al 90% en CIV sin reparación.